

anestesiologia

03 de Outubro de 2026

Questão 01

UFMA 2018 ACESSO DIRETO

Paciente com 32 anos de idade, masculino, com proposta de realização de gastroplastia videolaparoscópica, apresenta-se em consultório para realização de avaliação pré-anestésica. Tem 167cm de altura e pesa 118kg. Relata fazer caminhadas diárias de aproximadamente três quilômetros em esteira, sem dores no peito ou dispneia. Pressão arterial aferida em consulta de 118 x 70mmHg e frequência cardíaca de 84 batimentos por minuto. Antecedente de doença do refluxo gastroesofágico, tratado com omeprazol. Etilismo social. Sem outras comorbidades. Baseado nisso, o anestesiológista classificou corretamente o estado físico, segundo a American Society of Anesthesiologists como:

- A. P1, devido ao bom controle pressórico.
- B. P2, devido ao antecedente de refluxo gastroesofágico.
- C. P3, pelo índice de massa corporal $> 40 \text{ kg/m}^2$,
- D. P4, pelo porte cirúrgico.
- E. P5, pela baixa capacidade funcional.

Questão 02

SCM-BH 2018 ACESSO DIRETO

As formas de acesso à via aérea principal devem ser do conhecimento de todo médico, posto que é um procedimento que salva vidas, em qualquer ambiente de assistência à saúde. Na técnica correta para intubação, com que mão o laringoscópio deve ser segurado?

- A. Com a mão dominante do operador.
- B. Sempre com a mão direita.
- C. Com qualquer mão.
- D. Sempre com a mão esquerda.

Questão 03

UEPA 2025 ACESSO DIRETO

Uma mulher de 35 anos de idade, é admitida na unidade de terapia intensiva com taquicardia sinusal, taquipneia, hipotensão arterial e temperatura axilar de 39.5°C após colecistectomia videolaparoscópica eletiva. No exame físico é notável a rigidez muscular generalizada. No eletro presença de ondas T pontiagudas, desaparecimento das ondas P, alargamento do QRS e raras extrasístoles ventriculares. O medicamento que deve ser administrado imediatamente é:

- A. Noradrenalina.
- B. Paracetamol.
- C. Dantrolene.
- D. Hidrocortisona.
- E. Aspirina.

Questão 04

UNIFESP 2019 ACESSO DIRETO

Em relação à hipertermia maligna. Assinale a alternativa CORRETA:

- A. Trata-se de uma doença adquirida causada pela succinilcolina.
- B. É provocada pelo uso do anestésico inalatório halotano em concentrações muito elevadas.
- C. Pode ser controlada com diltiazem.
- D. A taquicardia e a elevação da concentração de CO₂ no gás exalado frequentemente antecedem a elevação da temperatura corporal.
- E. Não deve ser tratada com compressas geladas ou administração de fluidos gelados devido ao risco de CIVD por hipotermia.

Questão 05

HCPA-RS 2019 ACESSO DIRETO

Paciente de 63 anos, com 65 kg, foi trazido à emergência com ferimento por arma de fogo no abdome. Foi indicada a laparotomia exploradora. Os sinais vitais revelaram pressão arterial de 80 x 46 mmHg e frequência cardíaca de 142 bpm. O agente

de indução anestésica mais indicado é:

- A. Propofol.
- B. Tiopental.
- C. Etomidato.
- D. Lorazepam.
- E. Dexmedetomidina.

Questão 06

HUOL 2015 ACESSO DIRETO

Durante uma cirurgia de postectomia em um paciente de 50 kg, utilizaram-se 30 ml de lidocaína 2%, sem vasoconstritor para anestesia local. Essa dose é considerada:

- A. Segura, pois não ultrapassou a dose tóxica de 10 mg/kg.
- B. Segura, pois não ultrapassou a dose tóxica de 5 mg/kg.
- C. Insegura, e a principal complicação é o surgimento de broncoespasmo.
- D. Insegura, e a principal complicação é o surgimento de sonolência.

Questão 07

SUS-BA 2019 ACESSO DIRETO

Imagem do exame contrastado



Paciente, 52 anos de idade, sexo masculino, iniciou há 8 meses com disfagia, ora para sólidos ora para alimentos líquidos. Refere aumento da intensidade dos sintomas nos últimos meses, com perda ponderal de 5kg no período. Nega dor, febre ou outras queixas. Ao exame físico apresenta regular estado geral, emagrecido. Abdome escavado, indolor à palpação, sem visceromegalias.

Ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas, sem sopros. Murmúrio vesicular fisiológico sem ruídos adventícios. Distância tiromentoniana 6,5cm, distância esterno-mento 11cm, distância interincisiva 3cm. Classificação de Mallampati 2. Realizado exame contrastado. A melhor conduta para obtenção de via aérea, desse paciente, para a cirurgia é

- A. Intubação com paciente acordado.
- B. Intubação nasotraqueal após indução anestésica.
- C. Intubação orotraqueal após indução anestésica.
- D. Traqueostomia.

Questão 08

INEP 2015 REVALIDA

Uma menina de 7 anos de idade é levada à Unidade Básica de Saúde devido a acidente doméstico com ferimento corto-contuso do antebraço direito. A

lesão tem, aproximadamente, 12 cm de extensão, bordas

regulares com sangramento discreto e não ultrapassa a

fascia muscular. A criança pesa 20 quilogramas.

Para a

realização da sutura, dispõe-se de todo material cirúrgico e

de duas apresentações de anestésico local: lidocaína a 1%

sem vasoconstritor e lidocaína a 1% com vasoconstritor.

A vacinação antitetânica está em dia.

Após explicar o procedimento à paciente e à mãe, realizar

a antisepsia e a colocação de campos cirúrgicos, a

técnica anestésica mais adequada é

- A. A infiltrar a pele sadia ao redor do ferimento, utilizando lidocaína a 1% com vasoconstritor
- B. B infiltrar a pele sadia ao redor do ferimento, utilizando lidocaína a 1% sem vasoconstritor.
- C. C infiltrar o tecido subcutâneo por dentro da lesão, utilizando lidocaína a 1% com vasoconstritor

D. D infiltrar o tecido subcutâneo por dentro da lesão, utilizando lidocaína a 1% sem vasoconstritor.

Questão 09

UNESP 2024 ACESSO DIRETO

Adolescente de 18 anos, sem comorbidades, apresenta lesão accidental por faca em falange distal do segundo quirodáctilo. Peso 70 kg. A dose do anestésico local, para realização da sutura, deve ser no máximo de 35 mL de:

- A.** Lidocaína 1% sem vasoconstritor.
- B.** Lidocaína 1% com vasoconstritor.
- C.** Lidocaína 2% sem vasoconstritor.
- D.** Lidocaína 2% com vasoconstritor.

Questão 10

HOS-SP 2023 ACESSO DIRETO

Em relação à hipertermia maligna (HM), é correto afirmar que:

- A.** É uma crise hipermetabólica potencialmente fatal que se manifesta somente durante a exposição a um anestésico geral deflagrador em indivíduos suscetíveis.
- B.** Agentes anestésicos de inalação halogenados e relaxantes musculares despolarizantes causam uma diminuição na concentração de Ca^{2+} mioplásmico.
- C.** Quando indivíduos suscetíveis a HM são expostos a um anestésico deflagrador, ocorre a liberação anormal de Ca^{2+} , provocando ativação prolongada dos filamentos musculares, culminando com flacidez muscular e hipometabolismo.
- D.** Suspeita-se de suscetibilidade à HM no pré-operatório em pacientes com histórico familiar de HM ou histórico pessoal de mialgia após exercício, tendência ao desenvolvimento de febre, doença muscular e intolerância à cafeína.
- E.** O dantrolene é anestésico inalatório que, com maior incidência, desencadeia o desenvolvimento de HM em pacientes suscetíveis.

Questão 11

SES-GO 2025 ACESSO DIRETO

Os bloqueadores neuromusculares (BNM) são classificados de acordo com a duração de sua ação, levando-se como referência a sua meia vida de eliminação. De acordo com esta classificação, o:

- A.** Rocurônio é um BNM de duração ultracurta.
- B.** Atracúrio é um BNM de curta duração.
- C.** Vecurônio é um BNM de duração intermediária.
- D.** Cisatracúrio é um BNM de longa duração.

Questão 12

USP-SP 2022 ACESSO DIRETO

Homem de 65 anos de idade é admitido por insuficiência respiratória aguda no Pronto-Socorro. Durante o atendimento inicial, evolui com piora do padrão respiratório e da hipoxemia, optando-se por intubação orotraqueal. Nesse momento, a frequência respiratória é de 40 irpm, saturação de oxigênio de 88% com máscara não reinalante a 15L/min, frequência cardíaca de 120bpm e pressão arterial de 60x30 mmHg. Considerando a disponibilidade das quatro drogas abaixo, qual é a medicação de escolha para realizar a sedação deste paciente?

- A.** Fentanil.
- B.** Midazolan
- C.** Propofol.
- D.** Etomidato.

Questão 13

UFS 2020 ACESSO DIRETO

Um paciente de 18 anos, previamente hígido, está no pós-operatório imediato de hernioplastia inguinal, com anestesia peridural. Refere dor crescente em hipogástrio. Está ansioso e agitado. Pulso 110bpm, PA 120 x 90mmHg. Palpa-se massa dolorosa em hipogástrio. Descompressão brusca: negativa. A ferida cirúrgica tem bom aspecto. Conduta:

- A.** Ultrassom de abdome.
- B.** Passagem de sonda vesical.
- C.** Tomografia de abdome com contraste venoso.
- D.** Abertura e revisão da incisão.

Questão 14

FAMEMA 2026 ACESSO DIRETO

Considerando-se sedação e analgesia de procedimentos não eletivos, assinale a alternativa correta.

- A. Midazolam tem efeito cardiodepressor importante.
- B. Tempo de início de ação do etomidato é, em geral, de 2 a 5 minutos.
- C. Tempo de ação médio da cetamina é de 30 a 60 minutos.
- D. A ocorrência de quadro de hipotensão arterial é frequente quando do uso de fentanil.

Questão 15

UEPA 2022 ACESSO DIRETO

São preditores de via aérea difícil para intubação traqueal, EXCETO:

- A. Obesidade.
- B. Abertura da boca < 3 dedos.
- C. Mallampati III.
- D. Intubação traqueal prévia.
- E. Restrição à mobilidade cervical.

Questão 16

ENARE 2024 ACESSO DIRETO

Em um paciente com doença coronariana, qual dos seguintes agentes NÃO seria indicado para indução anestésica, por ter como efeito colateral a hipertensão?

- A. Tiopental.
- B. Propofol.
- C. Cetamina.
- D. Etomidato.
- E. Midazolam.

Questão 17

Anulada

SES-GO 2025 ACESSO DIRETO

Em uma vítima de agressão, pesando 80kg, com lesão cortante, extensa, com profundidade até

hipoderme, sem lesão muscular, nota-se que a sutura cutânea seria resolutive para o caso. Dentre os medicamentos disponíveis para a anestesia local, há lidocaína a 2% com vasoconstritor (1:200.000), contendo 20 ml em cada frasco. Qual o máximo de volume deste anestésico, sem diluição ou outro acréscimos, poderá ser administrado localmente, em região subdérmica, para a realização da sutura neste paciente, com segurança?

- A. Até 17 ml.
- B. Até 22 ml.
- C. Até 28 ml.
- D. Até 32 ml.

Questão 18

SCM-BH 2023 ACESSO DIRETO

Analise as assertivas a seguir: I- A analgesia preemptiva é a utilização da analgesia antes de causar a lesão cirúrgica. PORQUE; II- Este procedimento pode diminuir a intensidade da dor evitando a sensibilização central que é um mecanismo de amplificação da dor aguda. Sobre as assertivas, assinale a alternativa CORRETA:

- A. I é falsa e II é verdadeira.
- B. I e II são verdadeiras e II justifica I.
- C. I e II são verdadeiras, mas II não justifica I.
- D. I é verdadeira e II é falsa.

Questão 19

USP-RP 2025 ACESSO DIRETO

Homem, 52 anos, será submetido a colectomia subtotal devido a doença diverticular. O paciente tem hipertensão arterial e diabetes mellitus controlados com uso correto e regular de medicamentos. Qual a classificação pré-operatória desse paciente conforme os critérios de risco cirúrgico anestésico da Sociedade Americana de Anestesiologistas (ASA)?

- A. Asa I.
- B. Asa III.
- C. Asa II.
- D. Asa IV.

Questão 20

HIAE-SP 2017 ACESSO DIRETO

Considere os seguintes pacientes a seguir: 1- Paciente hipertenso, em uso de losartana, mantendo bom controle dos níveis pressóricos e Diabetes Mellitus, em uso de hipoglicemiantes orais, apresentando hemoglobina glicosilada dentro dos limites normais; 2- Paciente com morte cerebral declarada, cujos órgãos serão removidos para doação. Na avaliação de riscos perioperatórios, de acordo com a classificação da Sociedade Americana de Anestesiologia (ASA), os pacientes 1 e 2 são classificados, respectivamente, como:

- A. ASA I / ASA III
- B. ASA II / ASA VI
- C. ASA III / ASA V
- D. ASA I / ASA 0
- E. ASA II / ASA V

Questão 21

IAMSPE-SP 2020 ACESSO DIRETO

Em relação aos anestésicos locais, afirma-se: 1. São exemplos de anestésicos do grupo amida: tetracaína, lidocaína, bupivacaína e ropivacaína. 2. São bases fracas que carregam uma carga positiva no grupo amida, em pH fisiológico, tendo, portanto, sua ação prejudicada em meio ácido. 3. Seu mecanismo de ação é o bloqueio dos canais de cálcio nas membranas dos neurônios, sendo as fibras nervosas menores bloqueadas antes das fibras maiores. Em relação às afirmações, apenas:

- A. 1 e 2 são corretas.
- B. 2 e 3 são corretas.
- C. 1 e 3 são corretas.
- D. A 2 é correta.
- E. A 1 é correta.

Questão 22

USP-RP 2019 ACESSO DIRETO

Homem de 45 anos, hepatopata, foi admitido com quadro de hematemese volumosa com instabilidade hemodinâmica. Puncionado acesso venoso periférico para a reanimação inicial, porém, agora necessita de outro acesso venoso para administração

de aminas vasoativas e monitorização venosa central. Exames laboratoriais - hemoglobina: 9,5 g/dL; hematócrito: 30%; creatinina: 1,0 mg/dL; ureia: 40 mg/dL; plaquetas: 30.000 cel/mm³ tempo de protrombina (INR): 1,8; tempo de tromboplastina parcial ativada: 40 s. Qual é a melhor opção de acesso venoso dentre as alternativas abaixo?

- A. Punção de veia jugular interna.
- B. Dissecção de veia axilar.
- C. Dissecção de veia safena magna.
- D. Punção de veia jugular externa.

Questão 23

Anulada

ABC-SP 2026 ACESSO DIRETO

Sobre os anestésicos inalatórios e as suas características, assinale a alternativa correta.

- A. O óxido nitroso possui alta potência e alta solubilidade no sangue.
- B. O isoflurano tem baixa potência e pode induzir a bradicardia.
- C. O sevoflurano possui alta potência e solubilidade sanguínea baixa em comparação ao isoflurano e halotano.
- D. O desflurano é lentamente absorvido e também apresenta lentidão para ser metabolizado e eliminado.

Questão 24

UNIFESP 2022 ACESSO DIRETO

Homem, 55 anos de idade, ASA I, está no 2º PO de hernioplastia inguinal bilateral, realizada sob raquianestesia em punção lombar, com bupivacaína e morfina. Apresenta náuseas, prurido no abdômen e membros inferiores, intensa cefaleia occipital e temporal, irradiando para a região cervical, com piora na posição sentada ou ortostática. Sinais vitais: PA 130 x 90 mmHg e FC = 100 bpm. Qual é a conduta inicial mais adequada?

- A. Tampão sanguíneo peridural e opioide.
- B. Corticoide e dipirona.
- C. Hidratação e dipirona.
- D. Metoclopramida e opioide.

Questão 25

Intubação em sequência rápida tem sido a técnica padrão para o manuseio da via aérea na emergência e se baseia na indução com sedativo de ação rápida, de um bloqueador neuromuscular. Com relação a essa técnica, assinale a alternativa CORRETA

- A. Trata-se da técnica de escolha para pacientes com via aérea difícil, quando o médico não tem grande experiência.
- B. Está especialmente indicada quando existe urgência na intubação, como em pacientes com hipoxemia ou acidose metabólica graves.
- C. O uso de succinilcolina como bloqueador neuromuscular está formalmente contraindicado em pacientes com risco de desenvolver hipercalemia.
- D. O etomidato não deve ser empregado em pacientes com instabilidade hemodinâmica
- E. Uma das principais desvantagens dessa técnica é o aumento do risco de broncoaspiração.

Questão 26

HCPA-RS 2026 ACESSO DIRETO

Analgesia pós-operatória multimodal é uma estratégia que visa associar fármacos com diferentes mecanismos de ação para promover um melhor controle da dor pós-operatória, reduzindo seus efeitos colaterais. Associe os fármacos a seus mecanismos de ação. 1 - Dipirona; 2 - Cetorolaco trometamol; 3 - Tramadol; 4 - Oxicodona; 5 - Buprenorfina. () Agonismo μ , κ e δ . () Inibição de recaptação da serotonina. () Inibição da ciclooxigenase 3. A sequência numérica correta, de cima para baixo, da coluna da direita, é:

- A. 3 - 4 - 2.
- B. 3 - 5 - 2.
- C. 4 - 3 - 1.
- D. 5 - 3 - 1.

Questão 27

SUS-PE 2013 ACESSO DIRETO

Paciente de 50 anos, portador de Neoplasia de Próstata com metástase óssea, vem apresentando dor em região lombar com pontuação 9 na Escala Visual

Analógica (EVA). Assinale a alternativa CORRETA em relação ao manejo de dor indicado pela OMS, para o paciente em questão:

- A. Iniciar tramadol 100 mg a cada 6 horas associado à dipirona 1 g a cada 6 horas.
- B. O uso de adjuvantes pode ser utilizado na ocorrência de dor neuropática. Além disso, pode ser considerado o uso de corticoide e bisfosfonato.
- C. Não se deve iniciar morfina nesta fase devido aos efeitos colaterais sistêmicos como náuseas, constipação e sedação.
- D. Iniciar morfina na dose de 10 mg a cada seis horas. Doses maiores ou com intervalos menores está contraindicada pelo risco de efeitos colaterais graves, como insuficiência respiratória, por exemplo.
- E. Iniciar fentanil transdérmico, uma vez que é bem tolerado devido à menor presença de efeitos colaterais.

Questão 28

PUCSP 2024 ACESSO DIRETO

Um homem de 47 anos com hipertensão controlada com Lisinopril e Amlodipina apresenta um abaulamento doloroso na virilha direita sem história cirúrgica prévia. Ele é diagnosticado com hérnia inguinal e está agendado para reparo eletivo. Trinta minutos após o início da cirurgia, seu CO_2 expirado começa a subir, com pressão arterial de 160x95 mmHg, frequência cardíaca de 110 batimentos/minuto e temperatura de 39,1 °C. Qual é a causa mais provável da alteração nos sinais vitais?

- A. Estenose da artéria renal não diagnosticada.
- B. Liberação de catecolaminas de um tumor adrenal.
- C. Bloqueio muscular esquelético não despolarizante.
- D. Bloqueio despolarizante do músculo esquelético.

Questão 29

FAMEMA 2025 ACESSO DIRETO

Paciente de 24 anos sofre acidente motociclístico, e a proteção da via aérea será necessária ainda em ambiente pré-hospitalar. Com base nesse contexto, em relação a sedação e analgesia,

é correto afirmar que:

- A. O etomidato pode reduzir o limiar convulsivo.
- B. O tempo de ação do midazolam é, em média, de 15 a 30 minutos.
- C. A meia-vida da quetamina é curta, de maneira geral.
- D. A ocorrência de hipotensão após o uso de fentanil é bastante frequente.

Questão 30

AMRIGS 2018 ACESSO DIRETO

Paciente que está sendo submetido à drenagem de abscesso com anestesia local refere, durante o procedimento, gosto metálico na boca. A hipótese mais provável para esse sintoma é reação:

- A. Normal devido à ansiedade do paciente.
- B. Alérgica ao anestésico local.
- C. Resultante de intoxicação anestésica.
- D. À injeção do anestésico em meio ácido devido ao processo infeccioso local.
- E. À dor proveniente do abscesso.

Questão 31

UERN 2020 ACESSO DIRETO

Uma criança de 7 anos de idade é submetida a laparotomia exploradora para esclarecimento diagnóstico de dor abdominal. Após cerca de 30 minutos do início da anestesia, nota-se hiperpirexia (42 °C), taquicardia, rigidez e cianose. Exames laboratoriais revelam hipercalcemia, hipercalemia e acidose metabólica. O diagnóstico mais provável para essa condição é:

- A. Síndrome maligna associada aos neurolépticos.
- B. Reação anafilática.
- C. Hipertermia maligna.
- D. Processo infeccioso não diagnosticado no pré-operatório.

Questão 32

HCPA-RS 2020 ACESSO DIRETO

Paciente de 56 anos, tabagista, foi diagnosticado com adenocarcinoma de pulmão. Após

estadiamento da doença, será submetido a uma lobectomia aberta para ressecção do tumor. Que planejamento anestésico, dentre os abaixo, deveria ser empregado para que sejam obtidos os melhores desfechos perioperatórios?

- A. Anestesia geral.
- B. Raquianestesia.
- C. Anestesia peridural.
- D. Anestesia geral associada à raquianestesia.
- E. Anestesia geral associada à analgesia peridural torácica contínua.

Questão 33

HOS-SP 2025 ACESSO DIRETO

O agente anestésico inalatório não indicado em presença de espaços aéreos fechados, como procedimentos laparoscópicos, pneumotórax, obstrução intestinal, operações do ouvido médio ou retina, é o:

- A. Óxido nitroso.
- B. Halotano.
- C. Propofol.
- D. Etomidato.
- E. Tiopental.

Questão 34

ENARE 2021 ACESSO DIRETO

Um paciente com indicação de cirurgia apresentou, logo após a anestesia, taquicardia, temperatura elevada, arritmia e espasmo do músculo masseter. Sobre o provável diagnóstico desse quadro, suas características e manejo, assinale a alternativa correta.

- A. Trata-se de choque séptico que deve ser tratado com infusão imediata de antibiótico.
- B. Trata-se de hipotermia maligna e deve ser administrado Dantrolene.
- C. Trata-se de hipertermia maligna, condição autossômica dominante.
- D. Trata-se de choque séptico refratário e deve ser administrado sevoflurano.

E. Trata-se de hipertermia maligna e deve ser administrada succinilcolina.

Questão 35

UFRJ 2022 ACESSO DIRETO

O achado ao exame físico, na visita pré-anestésica, que mais corrobora um manejo potencialmente difícil das vias aéreas é:

- A. A) classificação de Mallampati II
- B. B) distância tiromental = 10cm
- C. C) pescoço longo
- D. D) abertura de boca = 2 dedos

Questão 36

SCM-SP 2022 ACESSO DIRETO

Um paciente foi admitido no pronto-socorro com quadro clínico de choque séptico de foco pulmonar. Foram indicadas a administração de noradrenalina e a passagem de acesso venoso central em veia jugular interna direita, pela via central. Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que a punção envolve a localização do marco anatômico, no ápice do triângulo formado pela(s)

- A. Cabeças do músculo esternocleidomastóideo e pela clavícula.
- B. Cabeças do músculo esternocleidomastóideo e pelo músculo platisma.
- C. Cabeças do músculo platisma e pela clavícula.
- D. Inserção do músculo escaleno e pelo músculo trapézio.
- E. Inserção medial do músculo esternocleidomastóideo e pelo músculo escaleno.

Questão 37

HUOL 2018 ACESSO DIRETO

O conhecimento da farmacologia dos anestésicos locais é de essencial importância para o médico generalista, pois seu uso inadequado pode levar a graves consequências. Sobre esse tipo de anestésico, é correto afirmar:

- A. Os injetáveis por via intravenosa diminuem o limiar à dor e causam hiperestesia.

B. A dormência periodontal e lingual é um sintoma precoce de intoxicação do sistema nervoso central.

C. A lidocaína e a procaína têm propriedades anticonvulsivantes quando ministradas em baixas doses.

D. Os do tipo amida são os de maior risco para desenvolvimento de hipertermia maligna.

Questão 38

UEPA 2026 ACESSO DIRETO

Uma mulher de 34 anos, previamente saudável, é submetida a colecistectomia videolaparoscópica sob anestesia geral com sevoflurano e succinilcolina. Cerca de 30 minutos após o término do procedimento, ainda na sala de recuperação anestésica, desenvolve taquicardia (160 bpm), hipertensão inicial seguida de hipotensão (70/40 mmHg), rigidez generalizada e temperatura central de 40,5°C. O anestesista relata aumento progressivo e inexplicado da concentração máxima de CO₂ exalada ao final da expiração e corresponde (ETCO₂) intraoperatório. A gasometria arterial e exames mostram: pH- 7.10; PaCO₂- 75mmHg; PaO₂- 103mmHg; HCO₃⁻- 13mEq/L; Lactato- 8,1 mmol/L; CPK- 9.500U/L e K⁺ 7,8 mEq/L. ECG demonstra QRS largo, ondas T apiculadas e extrassístoles ventriculares. A equipe se prepara para intubação de resgate e administração de gluconato de cálcio para estabilização de membrana. A próxima conduta prioritária que realmente muda a fisiopatologia do quadro, é:

- A. Gluconato de cálcio endovenoso.
- B. Dantrolene endovenoso.
- C. Bicarbonato de sódio em bolo endovenoso.
- D. Adrenalina em infusão contínua.
- E. Dipirona em infusão contínua.

Questão 39

FAMERP 2020 ACESSO DIRETO

Paciente de 65 anos de idade, admitida em unidade de emergência do Hospital de Base por quadro de dispneia há 2 dias associada a tosse produtiva com expectoração com aspecto purulento. Raio-X de tórax evidenciou imagem de hipodensidade em lobo médio e inferior direito. Foi-lhe prescrito ceftriaxone e claritromicina. Paciente evoluiu com piora do padrão respiratório e

hipotensão (pressão arterial média de 50mmHg). Foi indicada intubação orotraqueal (IOT) em Sequência Rápida uma vez que não haviam preditores de via aérea difícil. Levando-se em consideração o perfil de ação hemodinâmica das drogas abaixo, assinale a melhor opção a ser utilizada como droga sedativa para proceder à IOT:

- A. Quetamina
- B. Midazolam
- C. Propofol
- D. Fentanil

Questão 40

ENARE 2022 ACESSO DIRETO

Um paciente que será submetido a uma cirurgia teve indicação de anestesia raquidiana pela equipe de anestesia. Assinale a alternativa que apresenta somente informações corretas sobre esse bloqueio anestésico e que podem ser fornecidas ao paciente.

- A. A raquianestesia representa uma alternativa à manipulação da via aérea e evita as complicações da intubação orotraqueal.
- B. Na raquianestesia, pode haver despertar prolongado ou sonolência pós-operatória com alguma frequência.
- C. A raquianestesia apresenta vantagens por evitar efeitos colaterais como bradicardia e cefaleia.
- D. A raquianestesia apresenta a vantagem de poder ser realizada também em pacientes com cardiopatias e coagulopatias
- E. O risco de cefaleia pós-punção é baixo e ocorre com maior frequência em idosos do sexo masculino.

Questão 41

SES-PE 2021 ACESSO DIRETO

Em função da pandemia de Covid-19, a abordagem da via aérea em crianças passou por algumas modificações, a fim de garantir mais segurança para o paciente e para a equipe multiprofissional. Sobre esse tema, assinale a alternativa que contempla a melhor sequência para garantir uma adequada intubação orotraqueal (IOT) em pacientes

na emergência pediátrica com suspeita/confirmação de infecção por Covid-19, da chegada do paciente à unidade de saúde até a instalação da Ventilação Mecânica Assistida (VMA).

- A. Máscara não reinalante com FiO2 100%; bolus de ketamina e de rocurônio; IOT; midazolam e fentanila contínuo.
- B. Ventilação com pressão positiva com FiO2 100%; bolus de midazolam e de fentanila; IOT; rocurônio contínuo; se necessário, ketamina contínua.
- C. Máscara não reinalante com FiO2 100%; bolus de atropina e lidocaína; infusão contínua de ketamina e rocurônio; IOT; bolus de fentanila e ou midazolam
- D. Ventilação com pressão positiva com FiO2 a 100%, caso o paciente esteja em parada cardíaco-respiratória; IOT; iniciar massagem cardíaca; adrenalina in bolus a cada 3 minutos; bolus de rocurônio; se necessário, bolus de midazolam e fentanila.
- E. Máscara não reinalante com FiO2 100%; bolus de fentanila e midazolam; IOT; infusão contínua de ketamina e rocurônio.

Questão 42

IAMSPE-SP 2020 ACESSO DIRETO

Em relação aos anestésicos locais, assinale a alternativa CORRETA.

- A. A potência dos anestésicos locais tem relação direta com a lipossolubilidade da droga.
- B. Os do grupo amida têm reações alérgicas mais frequentes que os do grupo éster.
- C. A duração de ação dos anestésicos locais tem relação inversa com o seu grau de ligação às proteínas plasmáticas.
- D. A velocidade de ação dos anestésicos locais tem relação direta com o seu grau de ionização.
- E. Os do grupo amida têm metabolização pela pseudocolinesterase plasmática, fazendo com que sua duração anestésica seja menor, quando comparada aos do grupo éster.

Questão 43

UFSC 2020 ACESSO DIRETO

Um paciente de 67 anos é portador de hepatocarcinoma extenso e se queixa de dor de intensidade 8 (escala visual de dor). A dor está associada a náuseas e vômitos. Assinale a alternativa correta em relação ao manejo farmacológico da dor.

- A. Tramadol por via enteral
- B. Ibuprofeno por via enteral
- C. Morfina por via endovenosa
- D. Dipirona pela via subcutânea
- E. Dipirona e dexametasona por via endovenosa

Questão 44

UFPB 2018 ACESSO DIRETO

A intubação de sequência rápida é a melhor técnica para a intubação na sala de emergência. Sobre este procedimento, assinale a resposta errada:

- A. Preferencialmente os pacientes deverão estar com um acesso venoso de bom calibre, monitorizados de maneira completa disponível, inclusive com capnometria, embora na vida real, nem sempre isto seja completamente possível.
- B. Sobre o material utilizado, os tubos devem ser os maiores possíveis, em média com diâmetro interno de 7,5 a 8,0 mm para as mulheres e 8,0 a 8,5 mm para os homens, e os laringoscópios com lâminas curvas são preferíveis nos adultos.
- C. São indicações clássicas de intubação orotraqueal: fadiga da musculatura inspiratória em pacientes com risco de broncoaspiração, obstrução de vias aéreas, hipoxemia refratária, trabalho respiratório intenso, instabilidade hemodinâmica grave, proteção de vias aéreas, entre outras.
- D. As principais alterações ocorridas durante a laringoscopia e intubação orotraqueal são; aumento de pressão intracraniana, aumento de fluxo sanguíneo cerebral, aumento da resistência das vias aéreas, arritmias ventriculares, broncoconstrição, etc.
- E. A intubação nasotraqueal, tem como principais indicações, pacientes em parada cardiorrespiratória com intubação difícil causada por trauma craneano com fratura em base do crânio, nos quais hiperextensão do pescoço constitui-se uma técnica arriscada.

Questão 45

SUS-BA 2020 ACESSO DIRETO

Paciente, sexo feminino, 22 anos de idade, é trazida por familiares ao Pronto Socorro com história de ingestão de bebida alcoólica e droga ilícita (não sabem especificar a substância) durante uma festa, cursando com rebaixamento do nível de consciência e vômitos. Ao exame físico, regular estado geral, desorientada no tempo e no espaço, desidratada +2/+4, FC: 80bpm, PA: 118x74mmHg, FR: 24imp, ausculta cardíaca e respiratória sem alterações; Escala de coma de Glasgow 9 e pupilas midriáticas e fotorreagentes. O médico plantonista optou por realizar intubação orotraqueal para proteção da via aérea. Entre as condições abaixo, indique a que não prediz dificuldades na intubação.

- A. Obesidade.
- B. Anquilose da articulação temporomandibular
- C. Pescoço alongado.
- D. História de ronco durante o sono.

Questão 46

Anulada

USP-SP 2021 ACESSO DIRETO

Mulher de 28 anos de idade está no Pronto-Socorro com
Paciente de 20
USPSPSP2021R11Q98
anos é nuligesta e tem ciclos menstruais diagnóstico de pielonefrite obstrutiva. Será submetida à
passagem de cateter duplo-J. Tem medida de pressão arterial em
110/70 mmHg, frequência respiratória de 25 ipm, frequência
cardíaca em 120 bpm e está sonolenta. Qual hipnótico NÃO deve
ser utilizado na indução da anestesia geral com manobra de
sequência de intubação rápida desta paciente?

- A. Etomidato.
- B. Cetamina.
- C. Midazolam.
- D. Propofol.

Questão 47

Mulher de 28 anos, sem comorbidades, chega ao pronto-socorro com múltiplos ferimentos corto-contusos superficiais em membros inferiores devido fragmentação do vidro que compõe o boxe do banheiro, durante seu banho. Após limpeza e avaliação dos ferimentos, não foi percebido lesões de estruturas nobres, sendo iniciado a anestesia com lidocaína a 2 % e sutura da pele de cada ferimento. Após 40 minutos de procedimento, anestesiando os últimos ferimentos, paciente refere mal-estar geral e dormência perioral, evoluindo com alteração do nível de consciência. Quanto ao caso clínico, a conduta mais adequada é:

- A.** Substituir o anestésico local lidocaína por outro anestésico como bupivacaína, para terminar o procedimento.
- B.** Diluir a lidocaína a 2% com o mesmo volume de água destilada transformando-a em uma solução a 0,5%, e terminar o procedimento.
- C.** Terminar de anestésiar as feridas e abreviar o tempo de sutura solicitando a presença de um cirurgião.
- D.** Alcalinizar a solução de lidocaína com bicarbonato de potássio, o que provocaria menor tempo de latência e menor risco de evento adverso.
- E.** Parar o procedimento, iniciar hidratação endovenosa, oxigênio por cateter e posicionar o paciente em posição de Trendelenburg.

Questão 48

UFMA 2019 ACESSO DIRETO

Para drenagem de tórax de um paciente de 18 anos de idade, 85 kg, com quadro de pneumotórax espontâneo, um cirurgião utilizou 10 mL de uma solução diluída de lidocaína com vasoconstrictor a 0,5% para realização da anestesia local no quinto espaço intercostal direito. Após 10 minutos do início do procedimento, o paciente evolui com confusão mental e apresentou convulsões tônico-clônicas. Acerca do caso, assinale a alternativa CORRETA.

- A.** O uso de epinefrina na solução anestésica foi o principal responsável pelo evento.
- B.** A injeção no espaço intercostal está associada à maior absorção de anestésicos locais.
- C.** A abordagem inicial envolve administração imediata

de fenitoína endovenosa.

- D.** A dose tóxica da lidocaína foi ultrapassada, ocasionando convulsões.

Questão 49

SCM-BH 2017 ACESSO DIRETO

Você está no plantão, na sala de urgência de um grande hospital, e atende um paciente com história de quadro gripal há 3 dias, apresentando nas últimas 24 horas, tosse produtiva, febre alta. Ao exame, observa-se que o paciente fica gemente e abre os olhos apenas ao estímulo doloroso e tem resposta motora inespecífica. A frequência respiratória é de 46 incursões por minuto e ele usa toda musculatura acessória e satura 84% com suplementação de oxigênio por máscara facial com reservatório a 10L/min. Considerando o quadro descrito, assinale a alternativa CORRETA.

- A.** A distância esternomentoniana < 12,5cm e o índice de Comark-Lehane grau IV são indicadores de via aérea potencialmente difícil.
- B.** A intubação orotraqueal imediata é uma conduta adequada, posicionando o paciente com um coxim na região interescapular.
- C.** A máscara laríngea é um dispositivo supraglótico que pode ser usado rotineiramente como uma via aérea definitiva.
- D.** A ocorrência de hipotensão é rara após a intubação orotraqueal e a atenção deve ser toda voltada para os ajustes dos parâmetros ventilatórios no respirador.

Questão 50

UESPI 2024 ACESSO DIRETO

A respeito dos anestésicos locais, marque a alternativa CORRETA:

- A.** A) O radical aromático representa a estrutura lipofílica, relacionado com a potência e toxicidade dos anestésicos locais.
- B.** B) O grupo amina é a porção ionizável e responsável pela penetração no nervo.
- C.** C) A duração de ação da lidocaína é superior à da bupivacaína devido a maior afinidade proteica daquela.
- D.** D) A adrenalina adicionada ao anestésico local reduz a velocidade de absorção do anestésico local, diminui o risco de intoxicação, reduz o sangramento

cirúrgico e melhora a qualidade do bloqueio.

E. E) Todas as alternativas são incorretas.

Questão 51

UNICAMP 2021 ACESSO DIRETO

O bloqueador neuromuscular indicado para intubação em sequência rápida em paciente com estômago cheio é:

- A. A. Pancurônio.
- B. B. Atracurio.
- C. C. Succinilcolina.
- D. D. Vecurônio.

Questão 52

ENARE 2023 ACESSO DIRETO

Um paciente foi submetido a uma cirurgia abdominal, e o anestesista introduziu um cateter peridural para analgesia. O paciente se encontra na UTI utilizando heparina de baixo peso molecular como anticoagulação profilática, e a enfermeira questiona o médico plantonista se pode retirar o cateter. Nesse caso, qual é a conduta mais adequada e a respectiva justificativa?

- A. Retirar o cateter, já que a anticoagulação profilática não interfere no risco para hematoma epidural.
- B. Manter o cateter e solicitar orientação ao anestesista quanto ao momento da retirada, devido ao risco de hematoma epidural.
- C. O cateter poderá ser removido se a última dose de heparina tiver sido realizada há mais de 3h.
- D. Manter o cateter e aguardar, pelo menos, 48h, após a última dose da heparina para remover o cateter.
- E. Manter o cateter por, pelo menos, 24h, após a última dose de heparina devido ao risco de hematoma subdural.

Questão 53

Anulada

2026 ACESSO DIRETO

Na intubação orotraqueal no adulto de 70 kg, assinale a opção que corresponda à sequência correta dos eventos que devem ser realizados.

A. Oxigenação até, pelo menos, 85% de saturação, pressão sobre a cartilagem cricoide, administração de succinilcolina 100 mg, administração de etomidato 0,3 mg/kg, intubação por via orotraqueal e insuflação do cuff.

B. Oxigenar até obter 100% de saturação, pressão sobre a cartilagem cricoide, administração de succinilcolina 100 mg, administração de etomidato 0,3 mg/kg, insuflação do cuff e intubação por via orotraqueal.

C. Oxigenar até obter 100% de saturação, pressão sobre a cartilagem cricoide, administração de etomidato 0,3 mg/kg, administração de succinilcolina 100 mg, intubação por via orotraqueal, insuflação do cuff.

D. Oxigenação até pelo menos 85% de saturação, administração de succinilcolina 100 mg, administração de etomidato 0,5 mg/kg, pressão sobre a cartilagem cricoide, intubação por via orotraqueal e insuflação do cuff.

E. Oxigenar até obter 100% de saturação, administração de etomidato 0,5 mg/kg, administração de succinilcolina 100 mg, pressão sobre a cartilagem cricoide, intubação por via orotraqueal, insuflação do cuff.

Questão 54

ABC-SP 2022 ACESSO DIRETO

Considere que as drogas para sedação e analgesia foram muito utilizadas durante o período da pandemia da covid-19. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- A. O início da ação do etomidato é imediato (15 – 45 segundos).
- B. A duração do efeito da quetamina é, em geral, de 30 a 60 minutos.
- C. A infusão do fentanil deve ocorrer em até 10 minutos após a indução.
- D. O uso do midazolam está indicado quando se deseja o máximo de sedação.
- E. O propofol é a única droga que pode causar sedação e analgesia com manutenção da respiração espontânea.

Questão 55

USP-SP 2019 ACESSO DIRETO

Mulher, 28 anos de idade, antecedente cirúrgico, está realizando avaliação pré-anestésica para correção de hérnia inguinal. Relata ao anesteista que não sabe se possui alergia a medicamentos, mas possui alergia a pêssego, kiwi e mandioca. Qual outro tipo de alergia deve ser investigado antes da realização do procedimento?

- A. Lidocaina.
- B. Cetorolaco.
- C. Látex cirúrgico.
- D. Cefazolina.

Questão 56

SUS-PE 2012 ACESSO DIRETO

Sobre os anestésicos locais, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A. Agem bloqueando o potencial de ação dos impulsos nervosos através da inibição do influxo sódio nos canais de sódio.
- B. A adição de adrenalina prolonga seu tempo de ação, porém aumenta sua toxicidade sistêmica.
- C. A bupivacaína é mais potente e duradoura do que a lidocaína, embora com início de ação mais lenta.
- D. A bupivacaína tem maior toxicidade cardiovascular, e a lidocaína, neurológica.
- E. São menos efetivos em tecidos infectados e/ou inflamados.

Questão 57

SES-PE 2024 ACESSO DIRETO



A imagem abaixo retrata um acontecimento de 16 de outubro de 1846. William T.G. Morton demonstra a primeira administração bem-sucedida de anestesia geral. Este é um dos eventos mais significativos da história da medicina e ocorreu no Massachusetts General Hospital, sede da

Harvard School of Medicine. A data é hoje reconhecida mundialmente como o Dia Mundial da Anestesia devido à importância desse evento. Qual foi a substância utilizada nesse procedimento?

- A. Clorofórmio.
- B. Éter.
- C. Halotano.
- D. Tiopental.
- E. Morfina.

Questão 58

AMRIGS 2022 ACESSO DIRETO

Paciente pós-cirúrgico cardíaco a céu aberto, em sala de recuperação, começa a acordar e falar que quer ajuda para descer do leito, pois quer conversar com seus amigos que estão no restaurante, onde costuma almoçar, no mercado público da cidade. Segundo os argumentos do paciente, estão próximos ao seu automóvel, para o qual aponta, como se estivesse efetivamente estacionado naquele andar do hospital. O médico procura tranquilizar o paciente, porém este, à medida que se recupera do processo cirúrgico e anestésico, fica cada vez mais agitado e agressivo. Sobre o caso, assinale a alternativa INCORRETA.

- A. A solicitação de exames laboratoriais como hemograma, provas de função hepática e renais, eletrólitos, entre outros, podem auxiliar na elucidação da origem do quadro clínico.
- B. Trata-se de um quadro clínico característico de um paciente com Transtorno Delirante Tipo Somático prévio.
- C. Trata-se de um Transtorno Neurocognitivo, no caso, um quadro de delirium, podendo ser decorrente tanto do processo cirúrgico e anestésico quanto de abstinência ou intoxicação por fármacos ou outras substâncias.
- D. Este paciente apresenta, entre outras, alterações no nível de consciência, orientação e atenção.

Questão 59

UNIFESP 2024 ACESSO DIRETO

Homem, 75 anos de idade, será submetido a colectomia direita videolaparoscópica devido a tumor de cólon. Apresenta história de infarto do miocárdio

tratado com colocação de stent. Os exames pré-operatórios demonstram PA = 110/55 mmHg, FC = 58 bpm, SatO₂ = 96%. Ecocardiograma transtorácico apresentando FE 32%. Qual é hipnótico adequado para a indução da anestesia geral?

- A. Propofol.
- B. Midazolam.
- C. Etomidato.
- D. Cetamina.

Questão 60

UEPA 2022 ACESSO DIRETO

A insuficiência respiratória aguda é a principal indicação de ventilação mecânica na urgência. Com base nessa afirmação, a alternativa correta é:

- A. Mesmo em quadros de insuficiência respiratória em que a intubação traqueal estiver indicada, é recomendado iniciar ventilação não invasiva para evitar intubação.
- B. A gasometria arterial é pouco útil na diferenciação entre insuficiência respiratória aguda tipo 1 e tipo 2.
- C. Pacientes em insuficiência respiratória aguda grave podem ser pronados por mais de 12h ao dia quando não houver contraindicação.
- D. Em pacientes que necessitem de ventilação mecânica invasiva, valores da relação PaO₂/FiO₂ entre 150 e 250 mmHg são considerados normais.
- E. Ao exame físico, frequência cardíaca acima de 130 bpm é o sinal mais frequentemente encontrado em pacientes com insuficiência respiratória aguda.

Questão 61

Anulada

UFES 2016 ACESSO DIRETO

No atendimento ao paciente traumatizado quando abordamos a via aérea, é considerada uma via aérea definitiva, exceto:

- A. Tubo nasofaríngeo.
- B. Cricotireoidostomia.
- C. Traqueostomia.
- D. Tubo nasotraqueal.
- E. Máscara laríngea.

Questão 62

SUS-SP 2025 ACESSO DIRETO

Assinale a alternativa que apresenta os medicamentos empregados para a intubação orotraqueal em um adulto politraumatizado.

- A. Succinilcolina 100 mg seguida do etomidato 3 g/kg.
- B. Etomidato 0,3 mg/kg seguido da succinilcolina 1 a 2 mg/kg.
- C. Etomidato 3 g/kg seguido da succinilcolina 100 mg.
- D. Etomidato 70 g seguido da succinilcolina 100 mg.
- E. Succinilcolina 1 mg a 2 mg/kg seguido do etomidato 0,5 mg/kg.

Questão 63

INEP 2026 REVALIDA

Homem, 32 anos, é atendido em Unidade Básica de Saúde após acidente doméstico, com ferimento corto-contuso de aproximadamente 4 cm em antebraço esquerdo, sem contaminação grosseira. Ao exame físico, não há sinais de lesão vascular, tendínea ou neurológica. O tipo de anestesia e anestésico local mais indicado para o reparo da ferida é

- A. Infiltração de bordas com lidocaína 2% com vasoconstritor.
- B. Bloqueio do plexo braquial com bupivacaína a 0,5%.
- C. Infiltração local com bupivacaína 2% sem vasoconstritor.
- D. Bloqueio de nervo na fossa antecubital com ropivacaína 1%.

Questão 64

AMRIGS 2022 ACESSO DIRETO

Ferimento cortocontuso em extremidade do dedo da mão com sangramento profuso e intenso. Em relação à anestesia local, como proceder?

- A. Bloqueio troncular com lidocaína e vasoconstritor.
- B. Infiltração local com lidocaína com vasoconstritor.

C. Bloqueio troncular com lidocaína sem vasoconstritor.

D. Infiltração local com lidocaína sem vasoconstritor

Questão 65

PSU-MG 2017 ACESSO DIRETO

Homem de 38 anos de idade procura o cirurgião para retirada de lipoma na coxa direita. O procedimento é agendado em caráter ambulatorial sob anestesia local. Em relação aos anestésicos locais, assinale a alternativa ERRADA:

A. A associação da adrenalina, quando indicada, reduz a velocidade de absorção do anestésico local, diminui a incidência de intoxicação pelo anestésico e reduz o sangramento

B. A massa anestésica é o produto do volume pela concentração da solução utilizada. Assim um aumento na massa do anestésico local resulta em anestesia mais profunda, duradoura e com menor tempo de latência

C. A solubilidade lipídica parece ser o determinante primário da potência anestésica intrínseca, pois a membrana nervosa, que é o sítio da ação dos anestésicos locais, é composta por 90% de lipídeos e 10% de proteínas

D. O início de ação depende basicamente do pKa dos diferentes anestésicos locais, sendo a fração ionizada a responsável pela penetração tecidual e nervosa

Questão 66

IAMSPE-SP 2025 ACESSO DIRETO

O propofol é um dos agentes anestésicos intravenosos mais utilizados atualmente. Qual o principal mecanismo de ação do propofol que explica seu efeito hipnótico?

A. O propofol atua como agonista dos receptores NMDA, promovendo a inibição da transmissão sináptica.

B. O propofol inibe a liberação de acetilcolina nos terminais sinápticos, diminuindo a excitabilidade neuronal.

C. O propofol bloqueia os canais de sódio voltagem-dependentes, impedindo a despolarização das membranas neuronais.

D. O propofol facilita a ligação do GABA aos seus receptores, aumentando a condutância de íons cloreto e hiperpolarizando a membrana celular.

E. O propofol reduz a atividade da adenilciclase, diminuindo a concentração intracelular de AMPc e a atividade neuronal.

Questão 67

UNICAMP 2020 ACESSO DIRETO

Homem, 21a, vítima de projétil de arma de fogo em abdome é trazido à Unidade de Pronto Atendimento. Exame físico: PA= 60x38 mmHg, FC= 144 bpm, FR= 28 irpm, oximetria de pulso (sob máscara 100%)= 90%, letárgico, pele fria, enchimento capilar maior que 2 segundos, descorado +++/4+, Escala de Coma de Glasgow= 10 e pupilas isofotorreagentes. A MEDICAÇÃO A SER EVITADA DURANTE A INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL É:

A. Succilcolina.

B. Etomidato.

C. Midazolan.

D. Fentanil.

Questão 68

PUC-PR 2024 ACESSO DIRETO

Sobre a técnica de punção de um acesso venoso central guiada por ultrassonografia, assinale a CORRETA.

A. Na técnica dinâmica, deve-se realizar a medida da profundidade do vaso e então posicionar a agulha em um ângulo de 30 graus com a pele, entrando em linha reta sem a visualização direta da agulha.

B. O primeiro passo deve ser o reconhecimento das estruturas anatômicas, podemos diferenciar a veia jugular interna da artéria carótida realizando a compressão dos vasos. Nessa manobra espera-se que a artéria colabe durante a compressão.

C. O acesso de escolha para uso da técnica guiada por Ultrassonografia deve ser a veia subclávia, uma vez que está associado a menores taxas de complicações e de punção arterial inadvertida.

D. Na técnica estática, deve-se posicionar a veia no centro do monitor e realizar a inserção da agulha em um ângulo de 45 graus em relação ao transdutor

e equidistante deste com a veia.

E. A punção guiada por ultrassom dispensa o uso de técnica asséptica, uma vez que reduz o número de tentativas de punção.

Questão 69

SCM-SP 2024 ACESSO DIRETO

Ao realizar a excisão de um cisto sebáceo sob anestesia local em um homem de 60 kg, um cirurgião decide utilizar lidocaína a 1% sem vasoconstritor. Qual é o volume máximo seguro de lidocaína que pode ser administrado para garantir uma anestesia eficaz e minimizar os riscos de toxicidade?

- A. 20 mL.
- B. 30 mL.
- C. 40 mL.
- D. 50 mL.
- E. 60 mL.

Questão 70

UNESP 2020 ACESSO DIRETO

Criança de 3 meses foi submetida à cirurgia cardíaca para correção do defeito septal atrioventricular. A intubação e extubação orotraqueal ocorreram sem intercorrências. O tempo de intubação foi de três horas. Após a extubação, passou a apresentar choro baixo e fraco e leve estridor bifásico. Os sintomas mantiveram-se após uso de corticoide endovenoso. A hipótese diagnóstica é

- A. Estenose subglótica após intubação.
- B. Laringomalácia por malformação
- C. Paralisia de prega vocal esquerda por comprometimento do nervo laringeo recorrente.
- D. Laringite aguda viral sazonal.

Questão 71

UFPR 2018 ACESSO DIRETO

Levando em consideração os preditores de dificuldade de ventilação sob máscara, assinale a alternativa que apresenta o maior risco.

A. A) Paciente com 70 anos, usuário de prótese dentária.

B. B) Paciente com 30 anos e história de apneia do sono.

C. C) Paciente com IMC > 26 kg.m⁻² e falta de dentes.

D. D) Paciente com 150 kg e 80 anos.

E. E) Paciente com 70 anos e acromegálico.

Questão 72

UNESP 2023 ACESSO DIRETO

Homem de 70kg, será submetido a anestesia infiltrativa para exérese de pequeno lipoma em abdome. A dose máxima permitida de lidocaína que pode ser utilizada durante o procedimento é:

- A. 17,5 ml de lidocaína 2% sem vasoconstritor.
- B. 30 ml de lidocaína 2% com vasoconstritor.
- C. 21 ml de lidocaína 1% sem vasoconstritor.
- D. 17,5 ml de lidocaína 2% com vasoconstritor.

Questão 73

ENARE 2023 ACESSO DIRETO

Sobre a dor, assinale a alternativa correta.

- A. Os nociceptores são responsáveis pela transdução.
- B. A dor neuropática tem como principal característica a melhora à noite e nos meses mais frios.
- C. A migrânea é um exemplo clássico de dor somática superficial.
- D. A pregabalina atua nos receptores opioides do sistema nervoso central, principalmente $\mu 1$ e $\mu 2$.
- E. A presença de injúria tecidual é essencial para a explicação do fenômeno doloroso.

Questão 74

Anulada

SES-GO 2024 ACESSO DIRETO

Considere um paciente submetido a anestesia para cirurgia de grande porte e de alto risco, que desenvolve quadro de hipotensão moderada a severa por queda do débito cardíaco. A intervenção terapêutica para controle clínico mais útil, nesse caso, é fazer uso de infusão de:

- A. Solução venosa, solução cristaloide e droga inotrópica.
- B. Solução venosa e cristaloide e noradrenalina venosa.
- C. Droga reversora do anestésico e solução venosa cristaloide.
- D. Noradrenalina e dobutamina simultaneamente.

Questão 75

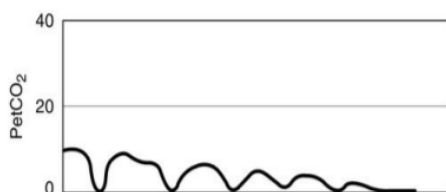
SES-PE 2020 ACESSO DIRETO

Homem, 63 anos, sofreu trauma abdominal fechado por atropelamento. Foi indicado laparotomia de emergência. Você participa da equipe anestésica que irá realizar o procedimento. A anestesista sugere que a intubação será difícil e adota várias medidas para o sucesso da obtenção da via aérea. Assinale a alternativa que contém métodos de avaliação de uma via aérea difícil.

- A. Mallanpati e ASA
- B. LEMON e Cormack-Lehane
- C. Mallanpati e ASIA
- D. LEMON e Hinchey
- E. MOANS e Cormack – Lehane

Questão 76

USP-SP 2022 ACESSO DIRETO



Homem de 65 anos de idade é admitido por insuficiência respiratória aguda no Pronto-Socorro. Durante o atendimento inicial, evolui com piora do padrão respiratório e da hipoxemia, optando-se por intubação orotraqueal. Nesse momento, a frequência respiratória é de 40 irpm, saturação de oxigênio de 88% com máscara não reinhalante a 15L/min, frequência cardíaca de 120bpm e pressão arterial de 60x30 mmHg. Após a intubação orotraqueal, a capnografia mostra a seguinte curva: Qual é o diagnóstico mais provável?

- A. Intubação esofágica.
- B. Pneumotórax.

- C. Intubação seletiva.
- D. Broncoespasmo.

Questão 77

UFSC 2020 ACESSO DIRETO

Homem, 82 anos, asilado em casa de cuidados, chega ao pronto atendimento com quadro de taquidispneia associada a febre e tosse produtiva. Gasometria arterial demonstrando acidose láctica grave associada a hipoxemia importante. Oximetria de pulso 82% com aporte de oxigênio a 100%, hipotensão arterial (PA 64 x 44mmHg) e Glasgow 7 pontos. A alternativa que apresenta a conduta MAIS acertada é:

- A. Ventilação não-invasiva por pressão contínua, por apresentar melhores resultados nesses casos.
- B. Intubação orotraqueal utilizando cetamina e succinilcolina como possíveis adjuntos farmacológicos.
- C. Ventilação mecânica guiada por metas, visando volumes correntes entre 10-12mL/kg de peso.
- D. Ventilação mecânica não-invasiva visando estratégia ventilatória protetora, visando PEEP fisiológica.

Questão 78

SCML-SP 2025 ACESSO DIRETO

Um paciente do sexo masculino, 37 anos, obeso (IMC de 36 kg/m²), portador de hérnia inguinal bilateral, será submetido a correção cirúrgica eletiva. No planejamento anestésico, considera-se utilizar anestesia regional. Sobre anestesia loco-regional na cirurgia de hérnias inguinais, é correto afirmar:

- A. A anestesia raquidiana (raquianestesia) é contraindicada em pacientes obesos por dificultar o acesso ao espaço subaracnóideo.
- B. A anestesia peridural contínua é a escolha absoluta para qualquer hérnia inguinal unilateral.
- C. Bloqueios dos nervos ílioinguinal e ílio-hipogástrico podem ser utilizados para analgesia cirúrgica em hérnias inguinais, principalmente em casos selecionados.
- D. O uso de anestesia geral é sempre preferível em pacientes obesos, independentemente do tipo de cirurgia de parede abdominal.

Questão 79

SMS-SP 2022 ACESSO DIRETO

Quanto aos acessos centrais, é correto afirmar que:

- A.** A via preferencial de acesso central é o acesso jugular à esquerda, onde a veia jugular interna é maior e mais superficial do que o lado contralateral.
- B.** Ao se deparar com um acesso central infectado, deve-se retirá-lo e esperar 24 horas para uma nova passagem de acesso.
- C.** Acessos venosos femorais possuem maiores taxas de infecções locais, mas não de infecções de corrente circulatória.
- D.** Acessos subclávios são os que possuem maiores taxas de punção arterial e devem ser sempre evitados.
- E.** A veia jugular interna possui trajeto mais retilíneo à direita, devendo ser acessada pelo triângulo de Sédillot, com técnica de Seldinger.

Questão 80

UNICAMP 2023 ACESSO DIRETO

Durante a laringoscopia na intubação orotraqueal é solicitado, para um integrante da equipe, realizar uma pressão no sentido posterior, superior e para a direita na laringe. A FINALIDADE PRINCIPAL DESTA MANOBRA É:

- A.** A. Comprimir o esôfago contra a coluna.
- B.** B. Auxiliar na visualização das cordas vocais.
- C.** C. Determinar a classificação de Mallampati.
- D.** D. Evidenciar grau de obstrução da via aérea.

Questão 81

HIAE-SP 2019 ACESSO DIRETO

Em relação aos procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, é correto afirmar:

- A.** As incisões de biópsias excisionais devem ser realizadas respeitando as linhas de força da pele, para melhor resultado estético.
- B.** A superdosagem de anestésicos locais pode causar sintomas neurológicos, como convulsões e, mesmo, parada respiratória.

C. Em procedimentos de cantoplastia, é recomendado utilizar anestésicos locais com adição de vasoconstritor, para diminuir o sangramento.

D. Nas drenagens de abscessos com processo inflamatório intenso, não há benefício em usar anestesia local.

E. As lesões cutâneas suspeitas de malignidade devem ser biopsiadas com margem de, no mínimo, 1,0 cm, para avaliação histológica inicial adequada.

Questão 82

SUS-BA 2020 ACESSO DIRETO

Paciente, sexo feminino, 22 anos de idade, é trazida por familiares ao Pronto Socorro com história de ingestão de bebida alcoólica e droga ilícita (não sabem especificar a substância) durante uma festa, cursando com rebaixamento do nível de consciência e vômitos. Ao exame físico, regular estado geral, desorientada no tempo e no espaço, desidratada +2/+4, FC: 80bpm, PA: 118x74mmHg, FR: 24imp, ausculta cardíaca e respiratória sem alterações; Escala de coma de Glasgow 9 e pupilas midriáticas e fotorreagentes. O médico plantonista identificou condições preditoras de via aérea difícil nesta paciente. Indique qual conduta pode complicar a intubação orotraqueal.

- A.** Intubar com paciente acordada.
- B.** Utilizar laringoscopia videoassistida.
- C.** Utilizar dispositivos como guia (Bougie).
- D.** Intubar após sedação.

Questão 83

PUC-PR 2025 ACESSO DIRETO

Durante o atendimento de um paciente politraumatizado, sem sinais de fratura de base de crânio, você identifica alterações de via aérea, na ventilação e na função neurológica que indicam obtenção de via aérea definitiva. Considerando o conceito de via aérea definitiva, assinale abaixo a alternativa que apresenta apenas opções adequadas.

A. Intubação orotraqueal; Intubação nasofaríngea; Máscara Laríngea; Cricotireoideostomia por punção.

B. Intubação orofaríngea; Máscara Laríngea; Tubo esofágico multilúmen; Intubação nasotraqueal.

C. Intubação orofaríngea; Máscara Laríngea; Cricotireoideostomia por punção; Traqueostomia Cirúrgica.

D. Tubo Nasofaríngeo; Tubo esofágico multilúmen; Cricotireoideostomia por punção; Traqueostomia Cirúrgica.

E. Intubação orotraqueal; Intubação nasotraqueal; Cricotireoideostomia Cirúrgica; Traqueostomia Cirúrgica.

Questão 84

PSU-MG 2021 ACESSO DIRETO

Com frequência, na prática clínica, o cirurgião utiliza a associação de adrenalina aos anestésicos locais. Essa associação vai determinar o(a):

A. Aumento da ligação protéica do anestésico local

B. Aumento do pKa do anestésico local

C. Redução da concentração plasmática do anestésico local

D. Redução da latência anestésica

Questão 85

UNIFESP 2025 ACESSO DIRETO

Mulher, 27 anos de idade, 55 kg e 1,65 m, submetida a raquianestesia e anestesia geral para tratamento cirúrgico de endometriose. Durante avaliação pré-anestésica foi identificado alto risco para náusea e vômito no pós-operatório. Com objetivo de reduzir o risco de ocorrência de complicação no pós-operatório, qual é a conduta mais adequada?

A. Anestesia balanceada com propofol, remifentanil e sevoflurano.

B. Anestesia inalatória com sevoflurano e óxido nítrico.

C. Anestesia combinada com propofol e isoflurano.

D. Anestesia venosa total com propofol e remifentanil.

Questão 86

SES-DF 2023 ACESSO DIRETO

Uma paciente de 72 anos será submetida a uma cirurgia eletiva de histerectomia aberta e, para isso, passa por uma consulta pré-anestésica. Diante do caso, o anestesista opta em associar um bloqueio anestésico para a paciente. Com base no caso clínico e nos bloqueios anestésicos, julgue o item a seguir. Caso o anestesista opte por colocar um cateter epidural, em geral, ele não deve ser colocado após 24 horas da última dose de heparina de baixo peso molecular (HBPM) e não deve ser removido antes de 12 horas após a última dose de HBPM.

A. CERTO.

B. ERRADO.

Questão 87

UFRJ 2024 ACESSO DIRETO

Estima-se a baricidade de uma solução de anestésico local dividindo-se a sua densidade pela densidade do líquido cefalorraquidiano (LCR) à 37°C. Pode-se afirmar, sobre a baricidade dos anestésicos locais, utilizados na raquianestesia, que:

A. A) Soluções de anestésicos locais preparadas em água possuem gravidade específica ligeiramente menor que o LCR e tendem a subir contra a gravidade.

B. B) Soluções hiperbáricas são menos densas que o LCR e tendem a seguir a gravidade após a injeção.

C. C) Soluções isobáricas são tão densas quanto o LCR e tendem a seguir a gravidade após a injeção.

D. D) A baricidade das soluções de anestésicos locais não é um fator determinante importante para o nível e duração da raquianestesia.

Questão 88

SMS-SP 2016 ACESSO DIRETO

A hipertermia maligna é uma desordem da musculatura esquelética que pode ocorrer após a exposição a alguns agentes anestésicos. Ocorrem contrações musculares incessantes, levando a um aumento do metabolismo das células musculares, gerando um aumento importante da temperatura corporal, além de taquicardia, arritmias, acidose, entre outras complicações. Qual dos agentes relacionados

está mais frequentemente envolvido na ocorrência de hipertermia maligna?

- A. Propofol.
- B. Rocurônio.
- C. Etomidato.
- D. Succinilcolina.

Questão 89 Anulada

USP-SP 2018 ACESSO DIRETO

Um paciente com ferimento corto-contuso em coxa direita apresenta-se na sala de sutura do pronto-socorro em que você está de plantão. Para a realização desta sutura você solicita um anestésico local para a infiltração. A técnica de enfermagem que está na sala de sutura informa da disponibilidade de lidocaína com e sem epinefrina e bupivacaína com e sem epinefrina. Dentre as alternativas abaixo, qual está correta sobre o uso de anestésicos locais?

- A. A dose do anestésico local com epinefrina é menor que a dose do mesmo anestésico sem epinefrina, pelo risco de intoxicação pelo vasoconstritor.
- B. A bupivacaína é preferencialmente indicada, comparada à lidocaína pela sua menor toxicidade cardíaca.
- C. A dose de bupivacaína que pode ser utilizada neste caso é de 10 a 15 mg/kg, dependendo da adição ou não de epinefrina.
- D. A dose de lidocaína que pode ser utilizada neste caso varia de 7 a 10 mg/kg, dependendo da adição ou não de epinefrina.

Questão 90

SCM-BH 2018 ACESSO DIRETO

Com relação às propriedades físico-químicas dos anestésicos locais, assinale a alternativa CORRETA.

- A. A solubilidade lipídica é que determina a potência de um anestésico.
- B. A latência de um anestésico depende principalmente da sua concentração.
- C. Os anestésicos são ácidos fracos, solúveis em água.
- D. A duração de ação de um anestésico está relacionada a seu pKa.

Questão 91

UESPI 2021 ACESSO DIRETO

Na utilização da lidocaína como anestésico local, para prevenir a toxicidade, devemos evitar utilização acima da dose máxima, que seria:

- A. A) 0,5mg/Kg sem vasoconstritor e 1mg/Kg com vasoconstritor.
- B. B) 1mg/Kg sem vasoconstritor e 2mg/Kg com vasoconstritor.
- C. C) 3mg/Kg sem vasoconstritor e 5mg/Kg com vasoconstritor.
- D. D) 5mg/Kg sem vasoconstritor e 7mg/Kg com vasoconstritor.
- E. E) 7mg/Kg sem vasoconstritor e 10mg/Kg com vasoconstritor.

Questão 92

UNIFESP 2019 ACESSO DIRETO

Paciente com 70 kg está sendo submetido à drenagem de abscesso no cotovelo, sob anestesia local com lidocaína a 1% com vasoconstritor. Após usar 20 ml da solução, o paciente continua apresentando sensibilidade dolorosa na região. Qual das alternativas explicaria o quadro?

- A. O vasoconstritor não deveria ser usado nesse tipo de situação.
- B. A sensibilidade dolorosa persistente constitui sinal precoce de toxicidade.
- C. O anestésico local continua em sua forma solúvel (ionizada).
- D. A bupivacaína a 0,25% com vasoconstritor deveria ter sido usada no lugar da lidocaína.
- E. A dose de anestésico utilizada foi insuficiente.

Questão 93

PSU-MG 2014 ACESSO DIRETO

A psicóloga C.S.D., de 32 anos, interna-se para operação de cesariana de urgência. Em relação aos cuidados anestésicos na grávida, assinale a afirmativa ERRADA:

- A. O risco aumentado de aspiração durante a indução anestésica pode ser amenizado com a utilização de entubação em sequência rápida e da

manobra de Sellick.

B. Deve-se monitorar a oximetria de pulso, capnografia e pressão arterial, pois a hipercapnia materna pode provocar acidose fetal.

C. Deve-se utilizar oxigenoterapia suplementar no intuito de manter a saturação de O₂ da hemoglobina em 90%.

D. Caso ocorra hipotensão durante a indução anestésica, deve-se manter fluxo sanguíneo placentário adequado às custas de reposição volêmica e, se necessário, usar drogas vasoativas.

Questão 94

HUOL 2016 ACESSO DIRETO

Os conhecimentos sobre as propriedades e os efeitos colaterais dos anestésicos locais são essenciais para a formação médica. A opção em que há uma afirmação CORRETA sobre os anestésicos locais é:

A. A ropivacaína possui longa duração com alto potencial de cardiotoxicidade.

B. A bupivacaína possui metabolismo renal e duração muito lenta.

C. A lidocaína possui metabolismo hepático e início de ação rápido.

D. A procaína possui metabolismo plasmático e duração lenta.

Questão 95

ABC-SP 2017 ACESSO DIRETO

Na classificação de Mallampati, a visualização da úvula, palato mole, palato duro e pilares, é:

A. I.

B. II.

C. III.

D. C.

Questão 96

SUS-SP 2015 ACESSO DIRETO

Um paciente de 40 anos de idade está no quarto pós-operatório de hernioplastia inguinal direita à Lichtenstein, feita sob raquianestesia. Queixa-se de muita cefaleia e de vômitos frequentes. Está descorado e desidratado. A ferida operatória

tem discreta hiperemia. Nega dor abdominal. Conduta mais apropriada:

A. Blood patch.

B. Benzodiazepínicos e analgésicos.

C. Analgésicos e antibioticoterapia tópica.

D. Antibioticoterapia oral.

E. Suspensão de opioides prescritos e reforço com analgésicos simples, mais frequentes.

Questão 97

Anulada

HCPA-RS 2024 ACESSO DIRETO

Paciente de 2 anos foi trazido à Emergência por febre, irritabilidade, má perfusão periférica e presença de petéquias no abdômen e nos membros inferiores. Considerando que será realizada punção lombar, que medicamento, dentre os abaixo, é o recomendado por seu melhor efeito sedativo e segurança de uso?

A. Cetamina.

B. Codeína.

C. Diazepam.

D. Dexmedetomidina.

Questão 98

UFMT 2017 REVALIDA

Sobre a anestesia subaracnóidea, assinale a afirmativa correta.

A. O espaço subaracnóideo só pode ser abordado pela via mediana.

B. A punção no interespaço L5-S1 é a mais segura.

C. Um dos fatores que influenciam a dispersão das soluções anestésicas injetadas no espaço subaracnóideo é a densidade da solução em relação à densidade do líquido

D. A cefaleia pós-anestesia subaracnóidea se agrava em decúbito dorsal.

Questão 99

UFMG 2015 ACESSO DIRETO

Paciente, 85 anos, cardiopata, politraumatizado, em choque classe IV, será submetido à cirurgia de emergência. Qual das drogas

abaixo tem melhor indicação na indução anestésica?

- A. Propofol.
- B. Etomidato.
- C. Cetamina.
- D. Tiopental.
- E. Diazepam.

Questão 100

ABC-SP 2017 ACESSO DIRETO

Droga de escolha para tratamento da hipertermia maligna:

- A. Soro fisiológico.
- B. Adrenalina.
- C. Amiodarona.
- D. Dantrolene sódico.

Questão 101

UNIFESP 2017 ACESSO DIRETO

Paciente é submetido à laparotomia exploradora sob anestesia geral venosa total. É colocado sob ventilação mecânica após indução e intubação traqueal. Dois minutos após, o valor do capnógrafo começa a apresentar queda lenta e progressiva. Este efeito é por:

- A. Depressão da ventilação.
- B. Volume corrente baixo.
- C. Frequência respiratória baixa.
- D. Hipotensão arterial.
- E. Intubação esofágica.

Questão 102

UNESP 2022 ACESSO DIRETO

Homem de 65 anos necessita de correção emergencial de fratura exposta e lesão vascular em membro superior esquerdo, com tempo cirúrgico estimado de 4 horas. AP: HAS, DM, obesidade grau II, roncos e sonolência durante o dia, dificuldade no manejo de via aérea em cirurgias anteriores. Exame físico: ansioso, PA 140/90 mmHg, edêntulo, com pequena abertura bucal (menor que 3,5 cm) e espaço submandibular

firme à palpação. Última refeição há 3 horas. A conduta mais indicada é:

- A. A. suspender o procedimento até que o tempo de jejum para sólidos seja de 8 horas.
- B. B. realizar indução e intubação sob sequência rápida, 00 evi02 tando ventilação sob pressão positiva durante etapa de pré-oxigenação.
- C. C. proceder com realização da cirurgia sob sedação e infiltração local, para que se evite manipulação das vias aéreas.
- D. D. prosseguir com intubação via fibroscopia óptica com paciente acordado e mantendo reflexos protetores de via aérea, antes de indução da anestesia geral.

Questão 103

PUCSP 2019 ACESSO DIRETO

Qual opção é menos segura para garantir uma via aérea difícil?

- A. Laringoscopia direta e intubação oral.
- B. Intubação endotraqueal com broncoscopia.
- C. Cricotiroidostomia.
- D. Máscara laríngea.

Questão 104

HOS-SP 2024 ACESSO DIRETO

É indicado o uso de fentanil na fase de pré-intubação da técnica de intubação por sequência rápida em caso de:

- A. Hipotensão arterial.
- B. Hipertensão intracraniana.
- C. Obesidade.
- D. Idade avançada.
- E. Hipoxemia.

Questão 105

UFES 2017 ACESSO DIRETO

Sobre a sedação de paciente sob ventilação mecânica invasiva, assinale a assertiva correta.

- A. A utilização de bloqueador neuromuscular deve estar condicionada a uma sedação profunda e monitorização adequada do nível de consciência.

B. Nível de sedação leve a moderado não permite controle da ansiedade, agitação e dor.

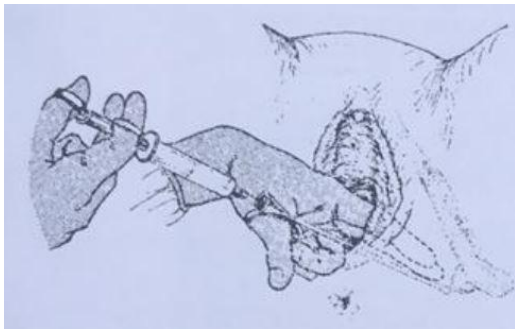
C. O nível de sedação deve ser intenso para permitir melhor tolerância ao ventilador.

D. Paciente que encontra-se acordado deve ter sua estratégia de sedação interrompida.

E. Qualquer agente que cause sedação e analgesia pode ser usado.

Questão 106

USP-SP 2019 ACESSO DIRETO



Qual é a referência anatômica utilizada para realizar o procedimento anestésico representado na figura abaixo?

A. Sínfise púbica.

B. Linha íleo pectínea.

C. Espinha isquiática.

D. Forame obturatório.

Questão 107

UESPI 2022 ACESSO DIRETO

Um médico na sala de cirurgia ambulatorial faz o planejamento de um procedimento de pequeno porte. Trata-se de um paciente do sexo masculino, com 30 anos, sem comorbidades ou alergia a medicamentos. Conclui que pode utilizar no máximo 400mg de lidocaína e precisa diluir a lidocaína 2% em 20ml disponível, até uma concentração de 0,5% para obter anestésico suficiente para o procedimento, sem ultrapassar a dose máxima segura. Assinale a alternativa CORRETA.

A. A) Preenchendo uma seringa de 20ml com lidocaína 2% e diluente na proporção de 1 para 1, podendo obter até 2 seringas a 0,5% do anestésico para o procedimento

B. B) Preenchendo uma seringa de 20ml com lidocaína

2% e diluente na proporção de 1 para 2, podendo obter até 3 seringas a 0,5% do anestésico para o procedimento.

C. C) Preenchendo uma seringa de 20ml com lidocaína 2% e diluente na proporção de 1 para 3, podendo obter até 4 seringas a 0,5% do anestésico para o procedimento.

D. D) A diluição da mesma quantidade de soluto de lidocaína com concentração inicial de 2% para uma a 0,5% não tem vantagem quanto à diminuição da sua toxicidade.

E. E) O uso de lidocaína com vasoconstritor não interfere na dose tóxica do anestésico local.

Questão 108

UNICAMP 2018 ACESSO DIRETO

Homem, 52a, com diagnóstico de espondilolistese com protrusão discal L5-S1, em uso de tramadol nas últimas 24 horas, foi submetido à cirurgia. Realizado midazolam no pré- anestésico, sendo a anestesia induzida com propofol, fentanil e rocurônio. Para prevenir vômitos, foi administrado ondansetrone e o bloqueio neuromuscular revertido com piridostigmina. Após extubação, queixou-se de náuseas, sendo administrado metoclopramida. Na reavaliação, o paciente apresentava desvio da visão para cima, rigidez muscular e pescoço fixo. Esses eventos são atribuídos a:

A. Ondansetrone e metoclopramida.

B. Rocurônio e piridostigmina.

C. Midazolam e tramadol.

D. Propofol e fentanil.

Questão 109

SURCE 2022 ACESSO DIRETO

Qual das seguintes características abaixo sugere uma via aérea difícil de ventilar/entubar?

A. Abertura da boca de 6 cm.

B. Cirurgia de artrodese cervical.

C. Distância tireoentoniana aumentada.

D. Visualização da úvula, no teste de Mallampati.

Questão 110

Paciente de 76 anos, sexo masculino, hipertenso, em uso de losartana, e diabético, em uso de metformina, vem apresentando bom controle clínico das comorbidades. Será submetido, em regime ambulatorial, à ressecção de lesão no membro inferior esquerdo sugestiva de melanoma. Considerando as informações acima, assinale a alternativa CORRETA.

- A. A idade do paciente deveria contraindicar a realização deste procedimento em regime ambulatorial.
- B. A anestesia geral não poderá ser realizada pois trata-se de cirurgia em regime ambulatorial.
- C. A associação de hipertensão e diabetes deveria contraindicar a realização desta cirurgia em regime ambulatorial.
- D. A raquianestesia poderá ser realizada desde que não haja contraindicações específicas.

Questão 111

PUC-PR 2026 ACESSO DIRETO

Paciente feminino, de 40 anos, com 60kg, referindo apenas ser portadora de DIU, sem outras comorbidades e portadora de lipoma de dorso, com plano de exérese sob anestesia local. Considerando a dose tóxica de lidocaína em 5mg/kg e de 7mg/kg quando associado a epinefrina, qual a quantidade máxima de lidocaína 1% com epinefrina, que pode ser usada com segurança para este paciente:

- A. 30 a 40ml.
- B. 50 a 60 ml.
- C. 60 a 70ml.
- D. 70 a 80ml.
- E. 80 a 100ml.

Questão 112

FAMEMA 2024 ACESSO DIRETO

Com relação ao procedimento de sedação e analgesia, assinale a alternativa correta.

- A. A) A ketamina possui uma importante ação ansiolítica e doses repetidas se acumulam no tecido adiposo.

B. B) Pacientes idosos ou com disfunção hepática estão sob maior risco de efeitos pronunciados e prolongados com o uso de fentanil.

C. C) Midazolam é a droga que mais efeito dissociativo (estado de transe) causa.

D. D) Ação do propofol inicia-se em 10-15 minutos, e tem sua duração média de 60 minutos.

Questão 113

HIAE-SP 2026 ACESSO DIRETO

Sobre as contraindicações e precauções relacionadas ao uso de anestésicos locais nas diferentes técnicas anestésicas, assinale a alternativa correta.

- A. A anestesia com lidocaína associada à adrenalina é contraindicada em bloqueios peridurais devido ao risco aumentado de neurotoxicidade.
- B. A anestesia tópica com lidocaína a 5% pode ser aplicada em mucosa oral em crianças pequenas, desde que a dose total não ultrapasse 10 mg/kg.
- C. A infiltração com lidocaína 1% associada à adrenalina 1:200.000 deve ser evitada em áreas com circulação terminal, como dedos, pênis, nariz e orelhas, devido ao risco de isquemia e necrose.
- D. A bupivacaína a 0,5% não deve ser utilizada para bloqueios de nervos periféricos por seu alto risco de toxicidade, sendo restrita à anestesia raquidiana com dose máxima de 5 mg/kg.

Questão 114

AMRIGS 2022 ACESSO DIRETO

Qual o mecanismo de ação do anestésico local?

- A. Bloqueio do canal de sódio.
- B. Bloqueio do epinervo.
- C. Bloqueio da bomba de prótons.
- D. Bloqueio da serotonina.

Questão 115

HUOL 2023 ACESSO DIRETO

Na avaliação pré-anestésica do paciente que vai se submeter a uma cirurgia não cardíaca, usam-se normas baseadas nas orientações do American

College of Cardiology e da American Heart Association. No que se refere às recomendações dessas entidades para a avaliação complementar pré-operatória de pacientes que realizarão cirurgia não cardíaca, pode-se:

A. Dispensar o eletrocardiograma de 12 derivações de rotina em pacientes assintomáticos que vão se submeter a procedimento cirúrgico de baixo risco.

B. Recomendar a investigação com angiografia de coronária de rotina nos pacientes com risco elevado e insatisfatória capacidade funcional.

C. Evitar o rastreio de rotina por meio de provas de esforço cardiopulmonar em pacientes que vão se submeter a procedimento cirúrgico de alto risco.

D. Indicar a avaliação da função do ventrículo esquerdo nos pacientes com risco elevado e excelente capacidade funcional.

Questão 116

Anulada

ABC-SP 2020 ACESSO DIRETO

Dentre os fármacos abaixo, assinale a alternativa que contenha um bloqueador neuromuscular despolarizante:

A. Pancurônio

B. Atracúrio

C. Succinilcolina

D. Neostigmina

Questão 117

FAMEMA 2026 ACESSO DIRETO

Durante a avaliação pré-operatória de uma cirurgia para correção do desvio de septo nasal, um paciente de 29 anos, previamente hígido, revelou estar em uso do medicamento naltrexona há seis semanas. Trata-se de um antagonista de receptores de opioide, utilizado no controle de abuso de álcool. Está programada a aplicação de anestesia geral para o procedimento. Nesse contexto, qual a recomendação clínica adequada?

A. Aumentar a dose de naltrexona para potencializar os efeitos de analgesia durante a cirurgia.

B. Manter o uso de naltrexona, com recomendação de abstinência total de álcool.

C. Substituir o naltrexona por um outro antagonista de opioides, como a naloxona.

D. Suspender o uso de naltrexona, por 3 ou mais dias, antes do procedimento e proibir o consumo de álcool.

Questão 118

ENARE 2022 ACESSO DIRETO

Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma complicação traqueal geralmente relacionada à intubação orotraqueal prolongada.

A. Estenose traqueal.

B. Fístula traqueoesofágica.

C. Fístula traqueoinominada.

D. Granuloma de traqueia.

E. Lesão do nervo facial.

Questão 119

UEPA 2022 ACESSO DIRETO

A sequência rápida de intubação (SRI) consiste na utilização de sedativo e bloqueador neuromuscular (BNM) em paciente pré-oxigenado. Sobre essa técnica, e os passos necessários para seu sucesso, é correto afirmar que:

A. A pré-oxigenação antecede a preparação das medicações a serem utilizadas no procedimento, para que se garanta o fornecimento máximo de oxigênio ao paciente.

B. A fase de pré-intubação (ou otimização) deve corrigir condições que aumentem o risco para o paciente, podendo-se indicar infusão de drogas vasoativas.

C. No último passo, pós-intubação, a medida de CO₂ expirado deve ser realizada somente após conexão do paciente ao ventilador pulmonar.

D. Na indicação do uso de fentanil para pacientes em SRI, sua infusão deve ser rápida, para diminuir o risco de síndrome do tórax rígido.

E. Antes de iniciar a SRI deve-se proceder à infusão contínua de BNM de meia vida curta para garantir o sucesso do procedimento.

Questão 120

UNICAMP 2016 ACESSO DIRETO

O período de jejum para leite materno exclusivo preconizado pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia é de:

- A.** Duas horas.
- B.** Quatro horas.
- C.** Seis horas.
- D.** Oito horas.

Gabarito

anestesiologia

03 de Outubro de 2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	D	C	D	C	D	A	B	A	D	C	D	B	A	D

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	-	B	C	B	D	D	-	C	C	C	B	D	A	C

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
C	E	A	C	D	A	C	B	A	A	A	A	C	E	C

46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
-	E	B	A	D	C	B	-	A	C	B	B	B	C	C

61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
-	B	A	C	D	D	C	D	B	C	C	A	A	-	B

76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
A	B	C	E	B	B	D	E	C	D	B	A	D	-	A

91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
D	C	C	C	A	A	-	C	B	D	D	D	D	B	A

106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
C	C	A	B	D	A	B	C	A	A	-	D	E	B	B